Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AUFKLÄRUNGS- UND EINWILLIGUNGSBOGEN

Otoplastik

Operation zur Korrektur abstehender Ohren (Ohranlegeplastik)

Liebe Patientin, lieber Patient, dieser Bogen soll Ihnen in **einfacher und verständlicher Sprache** erklären, was Sie über den Ihnen empfohlenen Eingriff wissen sollten. Er soll Ihnen keine Angst machen, sondern Ihnen helfen, Ihre Entscheidung **frei und gut informiert** zu treffen.

Bitte lesen Sie diesen Bogen in Ruhe durch. Fragen Sie Ihren Arzt nach allem, was Sie nicht verstehen. Ihr Arzt wird Ihnen außerdem mündlich die Risiken erläutern, die speziell in Ihrer Situation bestehen. Ob Sie Ihre Einwilligung geben oder nicht, ist allein Ihr Recht.

ANGABEN ZU PATIENT/IN UND EINGRIFF

Vor- und Nachname: _____ Geburtsdatum: _____

Reisepass- / Ausweisnummer: _____ Akten- / Protokollnummer: _____

Telefon: _____ Datum der Aufklärung: _____

Geplantes Datum des Eingriffs: _____

Bogen erstmals an Patient/in übermittelt (Datum / E-Mail, WhatsApp, persönlich): _____

Durchführender und aufklärender Arzt: **Op. Dr. Murat Ayata**

Krankenhaus / Einrichtung, in der der Eingriff durchgeführt wird: _____

Seite: ☐ Rechts ☐ Links ☐ Beidseits

Art der Betäubung: ☐ Vollnarkose ☐ Örtliche Betäubung ☐ Örtliche Betäubung + Sedierung

Zu korrigierende Bereiche / Erwartungen der Patientin / des Patienten: _____

1 Ihre Erkrankung und das Ziel des Eingriffs

Abstehende Ohren sind Ohren, die in einem größeren Winkel als üblich vom Kopf abstehen oder bei denen sich die natürliche Falte des Ohrknorpels (Anthelix) nicht ausgebildet hat. Die Veränderung ist meist angeboren, gesundheitlich unbedenklich und beeinträchtigt das Hören nicht. Vor allem im Kindes- und Jugendalter kann sie jedoch zu Hänseleien, Verlust des Selbstvertrauens und sozialen Ängsten führen.

Ziel der Otoplastik ist es, die Ohren näher an den Kopf zu bringen, sodass sie **natürlich** und auf beiden Seiten möglichst **ausgewogen** aussehen. Da die Ohrmuschel mit etwa 5–6 Jahren den größten Teil ihrer Erwachsenengröße erreicht, kann die Operation **ab einem Alter von 5–6 Jahren** durchgeführt werden; ein Eingriff vor dem Schulalter kann verhindern, dass das Kind sozial belastet wird. Soll Ihr Kind operiert werden, ist es wichtig, seine eigenen Wünsche und seine Bereitschaft zu berücksichtigen.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Wie wird der Eingriff durchgeführt?

Die Operation wird im Operationssaal durchgeführt. Bei Kindern wird meist eine Vollnarkose gewählt; bei Erwachsenen eine örtliche Betäubung (bei Bedarf mit Sedierung) oder eine Vollnarkose.

1. **Planung und Anzeichnung:** Die Ohren werden fotografiert, ihr Abstand zum Kopf wird gemessen, und die Lage der neuen Falte wird angezeichnet.
2. **Schnitt:** Der Hautschnitt erfolgt an der **Rückseite des Ohres**, nahe der natürlichen Falte zwischen Ohr und Kopf. Da diese Narbe hinter dem Ohr liegt, ist sie in der Regel nicht sichtbar.
3. **Formung des Knorpels:** Mit dauerhaften Nähten wird im Ohrknorpel eine neue Falte (Anthelix) gebildet. Falls nötig, wird der Knorpel ausgedünnt oder leicht eingeritzt, um ihn geschmeidiger zu machen.
4. **Anlegen des Ohres:** Ist die tiefe Mulde der Ohrmuschel (Concha) groß, wird sie verkleinert oder mit Nähten am Gewebe hinter dem Ohr fixiert. Steht auch das Ohrläppchen ab, wird es korrigiert.
5. **Wundverschluss und Verband:** Die Haut wird mit Nähten verschlossen. Ein weicher, leicht komprimierender Kopfverband wird angelegt, um die neue Form der Ohren zu halten und einer Blutansammlung vorzubeugen.

BETÄUBUNG (ANÄSTHESIE)	VORAUSSICHTLICHE DAUER	KRANKENHAUSAUFENTHALT / ENTLASSUNG
Bei Kindern Vollnarkose; bei Erwachsenen örtliche Betäubung ± Sedierung oder Vollnarkose	Etwa 1–2 Stunden (beide Seiten)	In der Regel Entlassung am selben Tag

3 Erwarteter Nutzen und Erfolgsaussichten

- Ohren, die näher am Kopf anliegen und natürlich aussehen
- Ein ausgewogeneres Erscheinungsbild beider Ohren
- Weniger soziale Ängste und Hänseleien wegen des Aussehens; ein Gewinn an Selbstvertrauen

Die meisten Patientinnen und Patienten und ihre Familien sind mit dem Ergebnis zufrieden. Da Ohrknorpel ein elastisches Gewebe ist, wird in Fachveröffentlichungen berichtet, dass sich das Ohr bei etwa **5–10 von 100** Patientinnen und Patienten teilweise wieder nach vorne aufrichten kann und eine Korrektur notwendig werden kann. Unterschiede von wenigen Millimetern zwischen beiden Ohren gelten als normal.

4 Andere Behandlungsmöglichkeiten

- **Keine Operation:** Abstehende Ohren verursachen keine gesundheitlichen Probleme, daher ist eine Operation nicht zwingend erforderlich.
- **Formung mit Schienen (Ohrformer) im Neugeborenenalter:** In den ersten Wochen nach der Geburt ist der Ohrknorpel sehr weich und kann mit speziellen Formern geformt werden; nach diesem Zeitraum ist dies nicht mehr wirksam.
- **Kaschieren durch die Frisur:** Frisuren, die die Ohren bedecken, können ihr Aussehen verbergen.
- **Schnittfreie Techniken / Fadentechniken:** Bei ausgewählten Patientinnen und Patienten mit weichem Knorpel kann die Korrektur über winzige Schnitte erfolgen; die Rückfallrate kann höher sein als bei der herkömmlichen Operation.

5 Was geschieht, wenn der Eingriff nicht durchgeführt wird?

Wird die Operation nicht durchgeführt, bleibt die Form der Ohren unverändert; sie bessert sich mit der Zeit nicht von selbst. Abstehende Ohren stellen keine Gefahr für die Gesundheit dar; die Entscheidung für eine Operation hängt ausschließlich vom Aussehen und vom Wunsch der betroffenen Person ab (bei Kindern vom Wunsch des Kindes und der Familie).

Sie haben das Recht, den empfohlenen Eingriff abzulehnen, ihn zu verschieben oder eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Diese Entscheidung hat keinerlei Einfluss auf andere medizinische Leistungen, die Ihnen angeboten werden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen; bitte beachten Sie jedoch, dass es nach Beginn eines Eingriffs Phasen geben kann, in denen ein Abbruch medizinisch nicht vertretbar wäre.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

6 Vorbereitung auf den Eingriff

- Vor der Operation werden die notwendigen Blutuntersuchungen durchgeführt; ist eine Vollnarkose geplant, werden Sie bzw. Ihr Kind vom Narkosearzt untersucht.
- Bei Vollnarkose oder Sedierung darf **6–8 Stunden** vor der Operation nichts gegessen und nichts getrunken werden (bei kleinen Kindern gilt die vom Narkosearzt angegebene Zeit).
- Waschen Sie am Morgen der Operation die Haare mit Shampoo. Lange Haare können so zurückgebunden werden, dass sie vom Operationsgebiet ferngehalten werden.
- Bei einer aktiven Hautinfektion, einem Ekzem oder einem nicht abgeheilten Piercing im Bereich des Ohres kann die Operation verschoben werden.
- Teilen Sie Ihrem Arzt **alle Medikamente** mit, die Sie einnehmen (einschließlich Blutverdünnern, Aspirin, Schmerzmitteln, Medikamenten zur Gewichtsabnahme und Hormonpräparaten), sowie alle **pflanzlichen Mittel und Nahrungsergänzungsmittel** (z. B. Omega-3, Vitamin E, Ginkgo, Knoblauch, Ginseng, Fischöl). Setzen Sie kein Medikament eigenmächtig ohne ärztlichen Rat ab.
- Informieren Sie uns unbedingt über **Allergien**, Blutungs- oder Gerinnungsstörungen, Herz- und Lungenerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck oder Schilddrüsenerkrankungen, frühere Operationen sowie über Probleme, die Sie bei früheren Narkosen hatten.
- Wenn Sie möglicherweise schwanger sind oder stillen, teilen Sie uns dies bitte vor dem Eingriff mit.
- Rauchen und Nikotinprodukte beeinträchtigen die Wundheilung erheblich. Hören Sie nach Möglichkeit mindestens 2–4 Wochen vor dem Eingriff damit auf und rauchen Sie während der Heilungsphase nicht.

7 Heilungsverlauf: Was Sie erwartet

Erste 48 Stunden	Pochen, Spannungsgefühl und mäßige Schmerzen in den Ohren können auftreten und lassen sich mit Schmerzmitteln behandeln. Es wird empfohlen, mit erhöhtem Kopf zu schlafen. **Starke, immer weiter zunehmende Schmerzen auf einer Seite sind nicht normal** und müssen sofort gemeldet werden.
2.–7. Tag	Der Verband wird in der Regel bei einem Kontrolltermin zwischen dem **2. und 5. Tag** abgenommen, und die Ohren werden kontrolliert. Schwellungen, Blutergüsse und Berührungsempfindlichkeit der Ohren sind in dieser Phase häufig. Nach Abnahme des Verbands wird ein weiches **Stirnband (Ohrenband)** getragen. Kinder können in der Regel nach einer Woche wieder zur Schule gehen.
1.–2. Woche	Das Stirnband wird **in den ersten 1–2 Wochen Tag und Nacht** getragen, danach **4–6 Wochen lang nur nachts**. So wird verhindert, dass das Ohr im Schlaf nach vorne umknickt, und die Nähte werden geschützt. Nicht selbstauflösende Hautfäden werden, falls verwendet, am 7.–10. Tag entfernt.
3.–6. Woche	Der größte Teil der Schwellung bildet sich zurück. Kontaktsportarten, Schwimmen und Helme, die auf die Ohren drücken, sollten mindestens **4–6 Wochen** lang vermieden werden.
3.–6. Monat	Die Ohrfalten festigen sich, die Narbe verblasst, und das endgültige Aussehen wird sichtbar. Ein leichtes Taubheitsgefühl der Ohren bessert sich in diesem Zeitraum meist.

8 Mögliche Risiken und Komplikationen

Wie jeder medizinische Eingriff ist auch dieser Eingriff mit gewissen Risiken verbunden. Im Folgenden sind **zu erwartende vorübergehende Begleiterscheinungen** und **Komplikationen** getrennt aufgeführt und nach ihrer Häufigkeit geordnet. Die angegebenen Zahlen sind **ungefähre** Werte aus der medizinischen Fachliteratur; Ihr persönliches Risiko kann je nach Alter, allgemeinem Gesundheitszustand, Rauchen und früheren Operationen niedriger oder höher sein.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Die allermeisten Komplikationen sind **vorübergehend** und bessern sich bei angemessener Behandlung. Aufgeführt sind auch sehr seltene, aber schwerwiegende Ereignisse; dass sie hier stehen, bedeutet nicht, dass sie bei Ihnen auftreten werden, doch Sie sollten sie kennen, um eine informierte Entscheidung treffen zu können.

Zu erwartende, vorübergehende Begleiterscheinungen (keine Komplikationen – ein normaler Teil der Heilung)

- Schmerzen, Pochen und Spannungsgefühl in den ersten Tagen
- Schwellung und Blutergüsse an den Ohren (1–2 Wochen)
- Vorübergehendes Taubheitsgefühl der Ohrhaut und Kälteempfindlichkeit (Wochen bis Monate)
- Eine feine Narbe hinter dem Ohr, die mit der Zeit verblasst

Häufige Beschwerden (meist vorübergehend oder mit Behandlung rückläufig)

- **Tastbare oder durch die Haut tretende Fäden** — Bei etwa **5–10 von 100** Patientinnen und Patienten können die dauerhaften Nähte, die den Knorpel formen, Monate oder Jahre später hinter dem Ohr tastbar werden, durch die Haut treten oder einen kleinen entzündlichen Knoten (Granulom) bilden. Dies wird in der Regel mit einem einfachen Eingriff zur Entfernung des Fadens behoben.
- **Teilweiser Rückfall (Ohr richtet sich wieder nach vorne auf)** — Bei etwa **5–10 von 100** Patientinnen und Patienten kann sich das Ohr teilweise in Richtung seiner ursprünglichen Stellung zurückbewegen; bei Bedarf kann eine Korrektur durchgeführt werden.
- **Leichte Asymmetrie** — Die beiden Ohren sind nie völlig gleich; Unterschiede von wenigen Millimetern nach der Operation sind normal. Besteht ein deutlicher Unterschied, kann er korrigiert werden.

Gelegentliche Beschwerden

- **Blutansammlung im Ohr (Hämatom)** — Tritt bei etwa **1–3 von 100** Patientinnen und Patienten auf, meist innerhalb der ersten 48 Stunden. **Starke, immer weiter zunehmende Schmerzen auf einer Seite** sind das wichtigste Anzeichen. Es muss **dringend entlastet** werden, bevor es die Durchblutung des Knorpels gefährdet; bei verzögerter Behandlung können ein Knorpelschaden und eine bleibende Verformung („Blumenkohlohr“) entstehen.
- **Wundinfektion** — Tritt bei etwa **1–5 von 100** Patientinnen und Patienten auf; sie heilt in der Regel mit Antibiotika ab.
- **Verdickte Narbe oder Keloid** — Bei etwa **1–3 von 100** Patientinnen und Patienten, besonders bei dunklerer Haut oder Neigung zu Keloiden, kann sich hinter dem Ohr eine dicke, erhabene Narbe bilden. Sie kann eine Behandlung mit Kortisoninjektionen, Silikongel oder eine Operation erfordern und wiederkehren. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie schon einmal ein Keloid hatten.
- **Überkorrektur oder unnatürliches Aussehen** — Die Ohren können zu flach am Kopf anliegend wirken, die Falte kann zu scharf sein, oder der mittlere Teil des Ohres kann weiter hinten liegen als der obere und untere Teil („Telefonhörer-Deformität“); bei Bedarf kann eine Korrekturoperation durchgeführt werden.

Seltene oder sehr seltene, aber möglicherweise schwerwiegende Komplikationen

- **Entzündung der Knorpelhaut (Perichondritis)** — Tritt bei **weniger als 1 von 100** Patientinnen und Patienten auf. Sie äußert sich durch zunehmende Rötung, Schwellung, Überwärmung und starke Schmerzen am Ohr. Sie kann intravenöse Antibiotika (über die Vene) und bei Bedarf eine operative Reinigung erfordern; bei verzögerter Behandlung können Knorpelverlust und eine **bleibende Verformung** die Folge sein.
- **Durchblutungsstörung der Haut oder des Knorpels (Nekrose)** — Sehr selten; meist im Zusammenhang mit einem zu straffen Verband, einem unbehandelten Hämatom oder einer Infektion. Eine Wundbehandlung und manchmal eine wiederherstellende Operation können notwendig sein.
- **Dauerhaft vermindertes Gefühl oder chronische Schmerzen** — Ein Taubheitsgefühl der Ohrhaut oder Schmerzen bei Kälte können selten dauerhaft sein.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Verengung des Gehörgangs** — Sehr selten kann sich nach Verkleinerung oder Fixierung der Concha der Eingang des Gehörgangs verengen; eine Korrektur kann notwendig werden.

Allgemeine Risiken jedes operativen / medizinischen Eingriffs

- **Narkoserisiken:** Wird eine Vollnarkose oder Sedierung (Dämmerschlaf) durchgeführt, erläutert Ihnen der Narkosearzt deren Risiken (Übelkeit, Halsschmerzen, Zahnschäden, allergische Reaktion und sehr selten Herz- oder Lungenprobleme) gesondert, und Ihre Einwilligung wird auf einem **separaten Narkose-Aufklärungsbogen** eingeholt.
- **Blutung und Bluttransfusion:** Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten erforderlich. Bei einer schweren Blutung können Blut oder Blutprodukte notwendig werden; diese bergen eigene, sehr seltene Risiken (z. B. Allergie oder Infektion).
- **Infektion:** Eine Wundinfektion nach der Operation wird in der Regel mit Antibiotika behandelt; selten kann eine Drainage (Ableiten des Eiters) notwendig sein.
- **Blutgerinnsel in den Beinvenen (Thrombose) und in der Lunge (Lungenembolie):** Bei kurzen Operationen im Kopf-Hals-Bereich sehr selten. Frühes Aufstehen und Gehen senkt das Risiko. Hormonpräparate, Rauchen, starkes Übergewicht und frühere Blutgerinnsel erhöhen das Risiko.
- **Medikamentenallergie:** Auf die verwendeten Medikamente, Desinfektionsmittel, Pflaster oder Nahtmaterialien kann eine allergische Reaktion auftreten.
- **Narbenbildung und Heilungsstörungen:** Wie Narben verheilen, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich; sehr selten kann sich eine verdickte (hypertrophe) Narbe oder ein Keloid bilden.
- **Lebensgefahr:** Todesfälle bei geplanten Operationen im Kopf-Hals-Bereich sind heute äußerst selten; dennoch ist kein operativer Eingriff völlig frei von Risiken. Eine schwere Komplikation kann eine Behandlung auf der Intensivstation erforderlich machen und zu einer bleibenden Behinderung führen.

Diese Aufstellung umfasst nicht jede denkbare Komplikation; andere unvorhersehbare und sehr seltene Ereignisse können auftreten. Tritt eine Komplikation auf, plant Ihr Arzt die notwendige Behandlung und Nachsorge; dies kann eine zusätzliche Behandlung, Medikamente, Eingriffe oder eine erneute Operation erfordern.

9 Wann Sie sich sofort bei uns melden sollten

- **Starke Ohrenschmerzen auf einer Seite, die immer weiter zunehmen** (besonders in den ersten 48 Stunden) – dies kann ein Zeichen für eine Blutansammlung sein
- Zunehmendes Durchsickern von Blut durch den Verband oder ein mit Blut durchtränkter Verband
- **Fieber über 38,5 °C**, zunehmende Rötung, Schwellung, Überwärmung oder übel riechende Absonderung aus dem Ohr
- Ein Verband, der sich zu eng anfühlt, oder ein Ohr, das sich bläulich oder anders verfärbt
- Ein Schlag auf das Ohr oder eine plötzliche Veränderung seiner Form

Wenn eines dieser Anzeichen auftritt, rufen Sie unverzüglich Ihren Arzt an: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Wenn Sie uns nicht erreichen, suchen Sie die nächste Notaufnahme auf oder wählen Sie die 112 (Notrufnummer in der Türkei und in ganz Europa).

10 Hinweise zu Medikamenten und zum Alltag

- Lassen Sie den Verband nicht nass werden und nehmen Sie ihn nicht selbst ab, bevor er in der Praxis entfernt wird. Nach der Abnahme dürfen Sie ab dem von Ihrem Arzt empfohlenen Tag vorsichtig duschen.
- Tragen Sie das Stirnband regelmäßig für den Ihnen genannten Zeitraum; dies ist wichtig für ein dauerhaftes Ergebnis.
- Vermeiden Sie in den ersten Wochen, auf den Ohren zu liegen, die Ohren nach vorne zu knicken und Kleidung mit engem Halsausschnitt über die Ohren zu ziehen.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Schützen Sie die Ohren mindestens 3 Monate lang vor Sonne und starker Kälte; wegen des verminderten Gefühls können Sonnenbrand oder Erfrierungen unbemerkt bleiben.
- Beaufsichtigen Sie Ihr Kind, damit es nicht am Verband oder am Stirnband zieht.
- Nehmen Sie die Ihnen verordneten Medikamente (Antibiotika, Schmerzmittel usw.) in der empfohlenen Dosierung und für die empfohlene Dauer ein. Nehmen Sie Aspirin oder ähnliche Medikamente, die Blutungen verstärken können, nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ein.
- Trinken Sie nach der Operation bei Flügen oder Reisen von mehr als 4 Stunden reichlich Wasser, bewegen Sie sich regelmäßig und tragen Sie, falls empfohlen, Kompressionsstrümpfe; dies senkt das Risiko von Blutgerinnseln in den Beinen.
- Während der Heilungsphase wird empfohlen, keinen Alkohol zu trinken und auf Rauchen und Nikotinprodukte zu verzichten.
- Bitte nehmen Sie alle Kontrolltermine wahr. Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, kann die Nachsorge nach Ihrer Rückkehr per Online-Sprechstunde und Fotos/Videos fortgeführt werden; falls Sie einen Arzt vor Ort aufsuchen müssen, erhalten Sie einen schriftlichen Operationsbericht und unsere Empfehlungen.

11 Unerwartete Befunde während des Eingriffs, Gewebeproben und Blutprodukte

Ergibt sich während des Eingriffs eine unvorhergesehene Situation, hält sich Ihr Arzt an den Umfang des Eingriffs, in den Sie mit diesem Bogen eingewilligt haben. **Sofern keine Lebensgefahr und keine Gefahr eines schweren Organschadens besteht**, wird kein zusätzlicher Eingriff vorgenommen, in den Sie nicht eingewilligt haben; in diesem Fall wird der Eingriff an einem sicheren Punkt beendet, und Sie werden anschließend informiert, damit die Entscheidung gemeinsam mit Ihnen getroffen werden kann. Besteht Lebensgefahr, wird die Notfallbehandlung durchgeführt, die zum Schutz Ihres Lebens oder des Organs erforderlich ist.

Während des Eingriffs entnommenes Gewebe wird, wenn nötig, zur Sicherung der Diagnose zur **feingeweblichen (pathologischen) Untersuchung** eingesandt. Je nach Ergebnis kann eine weitere Behandlung oder Nachsorge erforderlich sein.

Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten notwendig und wird nur verabreicht, wenn sie lebenswichtig ist. Wenn Sie Blut oder Blutprodukte ablehnen (zum Beispiel aus religiösen Gründen), müssen Sie uns dies vor dem Eingriff mitteilen; die möglichen Folgen dieser Entscheidung werden gesondert mit Ihnen besprochen und unter „Informationen speziell für Sie“ festgehalten.

12 Fotos, Bildaufnahmen und Ihre personenbezogenen Daten

Vor und nach dem Eingriff können zur Planung, Verlaufskontrolle und Beurteilung des Ergebnisses **Fotos/Videos** angefertigt werden. Diese Aufnahmen sind Teil Ihrer Krankenakte und werden vertraulich behandelt. Ihre Aufnahmen werden **niemals für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit oder soziale Medien verwendet.**

Für jeden anderen Zweck dürfen Ihre Aufnahmen **nur mit Ihrer gesonderten und ausdrücklichen Erlaubnis** verwendet werden. Eine Ablehnung hat keinerlei Einfluss auf Ihre Behandlung, und Sie können Ihre Erlaubnis jederzeit widerrufen:

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Aufnahmen **ausschließlich für die medizinische Dokumentation und die Verlaufskontrolle der Behandlung** verwendet werden.

☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich nicht erkennbar bin** (Gesicht/Augenpartie abgedeckt).

☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich erkennbar sein kann**.

☐ Ich **erlaube keine** Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken / Ausbildungszwecken.

Ihre personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten werden nach dem türkischen Gesetz Nr. 6698 zum Schutz personenbezogener Daten (KVKK) und den einschlägigen gesundheitsrechtlichen Vorschriften zu Zwecken der Diagnose, der Behandlung und der Erfüllung gesetzlicher Pflichten von Personen verarbeitet, die der beruflichen Schweigepflicht unterliegen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren Datenschutzhinweisen.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

13 Informationen und Anmerkungen speziell für Sie (vom Arzt auszufüllen)

Patientenspezifische zusätzliche Risiken (Begleiterkrankungen, Medikamente, frühere Operationen), Einzelheiten der Planung, Erwartungen der Patientin / des Patienten, gestellte Fragen und gegebene Antworten. Gibt es nichts zu ergänzen, „keine" eintragen.

14 Erklärung der Patientin / des Patienten

- ☐ Ich habe diesen Bogen in meiner Sprache gelesen und verstanden. Ich hatte ausreichend Bedenkzeit, konnte Fragen stellen und habe zufriedenstellende Antworten erhalten.
- ☐ Meine Erkrankung, das Ziel des empfohlenen Eingriffs, wie, von wem und wo er durchgeführt wird, seine voraussichtliche Dauer, der erwartete Nutzen, die Erfolgsaussichten, die Alternativen und die möglichen Folgen, wenn er nicht durchgeführt wird, wurden mir mündlich und schriftlich erklärt.
- ☐ Die häufigen und die möglicherweise schwerwiegenden Risiken sowie die möglichen Folgen dieser Komplikationen (einschließlich der Möglichkeit, dass eine weitere Behandlung oder ein erneuter Eingriff bzw. eine erneute Operation notwendig wird) wurden mir erklärt. Mir ist bewusst, dass das Ergebnis eines medizinischen Eingriffs **nicht zu 100 % garantiert werden kann**.
- ☐ Ich habe zutreffende und vollständige Angaben zu meinem Gesundheitszustand, meinen Medikamenten, meinen Allergien und früheren Erkrankungen gemacht. Mir ist bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben die Risiken erhöhen können.
- ☐ Mir ist bewusst, dass die Befolgung der Anweisungen vor und nach dem Eingriff zum Ergebnis beiträgt und dass die Wahrnehmung der Kontrolltermine wichtig ist.
- ☐ Ich weiß, dass ich meine Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen kann. Mir ist bewusst, dass meine Unterschrift unter diesen Bogen den Arzt nicht von seiner Sorgfaltspflicht entbindet.
- ☐ Ich treffe diese Entscheidung aus freiem Willen und ohne Druck von irgendeiner Seite.
- ☐ Mir ist bewusst, dass das Tragen des Stirnbands für den empfohlenen Zeitraum nach der Operation zum Ergebnis beiträgt und dass die Nichtbefolgung dieser Anweisungen das Rückfallrisiko erhöhen kann.
- ☐ Mir ist bewusst, dass dieser Eingriff **ästhetischer Natur** ist, dass er medizinisch nicht notwendig ist und dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, ihn nicht durchführen zu lassen. Ich habe meine Erwartungen mit meinem Arzt besprochen, und das realistisch erreichbare Ergebnis wurde mir erklärt.
- ☐ Mir ist bewusst, dass weder eine vollkommene Symmetrie noch eine exakte Nachbildung des Aussehens auf einem Foto garantiert werden kann, dass das endgültige Ergebnis davon abhängt, wie mein Gewebe heilt, und dass in manchen Fällen ein Korrektureingriff notwendig sein kann.

- ☐ **Ich ERTEILE MEINE EINWILLIGUNG zu dem oben beschriebenen Eingriff.**
- ☐ **Den oben beschriebenen Eingriff LEHNE ICH AB. Die möglichen Folgen der Ablehnung wurden mir erklärt.**

Wir empfehlen, dass die Patientin / der Patient handschriftlich ergänzt: „Ich habe diesen Bogen gelesen und verstanden und willige ein."

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

15 Unterschriften

	VOR- UND NACHNAME	UNTERSCHRIFT	DATUM / UHRZEIT
Patient/in			
Gesetzliche/r Vertreter/in (Elternteil / Vormund) – Verhältnis zum Patienten:			
Aufklärender und durchführender Arzt			
Dolmetscher/in (falls erforderlich) – Sprache:			
Zeuge/Zeugin (falls erforderlich)			

Erklärung der Dolmetscherin / des Dolmetschers: Ich habe diesen Bogen und die mündlichen Erläuterungen des Arztes der Patientin / dem Patienten bzw. der gesetzlichen Vertretung vollständig und korrekt in eine für sie verständliche Sprache übersetzt.

FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN UNTER 18 JAHREN ODER MIT EINGESCHRÄNKTER EINWILLIGUNGSFÄHIGKEIT

Bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren wird die Einwilligung von einem **Elternteil oder dem gesetzlichen Vormund** erteilt. Das Kind wird seinem Alter und seiner Reife entsprechend aufgeklärt, und seine Meinung wird eingeholt. Bei nicht einwilligungsfähigen Patientinnen und Patienten erteilt die gesetzliche Vertretung die Einwilligung.

☐ Sofern wir das Sorgerecht gemeinsam ausüben, erkläre ich, dass der andere Elternteil über diesen Eingriff informiert ist und ihm zustimmt.

☐ Ich erkläre, dass keine gerichtliche Entscheidung und kein Streit über das Sorgerecht / die Vormundschaft besteht (falls doch, wurde dem Arzt das entsprechende Dokument vorgelegt).

Das Kind wurde altersgerecht aufgeklärt; Meinung des Kindes: _____

Dieser Bogen wurde in zwei Exemplaren ausgefertigt: Ein Exemplar verbleibt in der Patientenakte, eines erhält die Patientin / der Patient bzw. die gesetzliche Vertretung.

WIDERRUF DER EINWILLIGUNG (NUR AUSFÜLLEN, WENN SIE SICH ANDERS ENTSCHEIDEN)

Ich widerrufe die oben erteilte Einwilligung. Die möglichen Folgen des Widerrufs wurden mir erklärt.

Name, Unterschrift, Datum und Uhrzeit der widerrufenden Person (Patient/in bzw. Vertreter/in): _____

Dieser Bogen wurde in Übereinstimmung mit der türkischen Patientenrechteverordnung und den Grundsätzen der Türkischen Ärztekammer zur Aufklärung und Einwilligung erstellt. Er ergänzt das mündliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt, ersetzt es aber nicht.